个案报道

全麻肱骨骨折术后一过性失语1例并文献复习

宋小艳，陈 坤，戴建强，易建华

【关键词】麻醉，全身；肱骨骨折；失语症；手术后并发症

中图分类号：R683.413，R767.64 文献标识码：B 文章编号：1674-666X(2024)05-394-03

1 病历摘要

患者女性，75岁，体质量45 kg，身高148 cm。因“摔伤致右上臂肿痛、活动受限7 h”入院，诊断为右肱骨中上段骨折。既往患糖尿病多年，长期口服降糖药，血糖控制可；有脑梗塞病史，长期口服氯吡格雷75 mg抗血小板治疗，遗留左上肢、左下肢肌力下降；无精神疾病病史及药物滥用史。体格检查可见右上臂中上段肿胀明显，有局部环状压痛、可及骨擦感及异常活动，纵向叩击痛(+)，被动活动疼痛加重；除血糖偏高(7.84 mmol/L)外，余术前实验室检查结果无异常。

全麻下行右肱骨骨折切开复位内固定术。术前常规监测心电图、血压、脉搏和血氧饱和度，开放下肢外周静脉，快速静脉输注乳酸林格氏液500 mL。诱导前给予地塞米松10 mg，依托咪酯10 mg、阿芬太尼2.5 mg用于诱导，视频喉镜插管置入7.0加强型气管导管。连续输注丙泊酚中长链脂肪乳注射液(6～7 mg/kg/h)和瑞芬太尼(0.15～0.2 μg/kg/min)维持麻醉。期间给予静脉输入奥美拉唑40 mg、氨基己酸200 mL、平衡液500 mL、0.9%氯化钠注射液200 mL、羟乙基淀粉130/0.4电解质注射液1 000 mL。术程顺利，手术时间6 h，手术结束后予镇痛泵镇痛(氢吗啡酮2 mg、氟比洛芬酯50 mg、昂丹司琼16 mg)，患者无明显血压及心率波动，自主呼吸恢复，暂未拔气管插管，送返骨科监护病区监护治疗，转科前使用咪达唑仑2 mg静脉注射镇静。监护期间暂停镇痛泵，未再使用镇静镇痛类药物。入骨科监护病区约4 h清醒，拔管后能遵嘱动作，但无法言语，家属探视后仍不能发声。鉴于患者既往脑梗病史，且为手术治疗，停用氯吡格雷、以低分子肝素替代持续5 d。失语持续约40 h后行MRI检查，听家人提及长期未见的孙子，患者情绪激动，同孙子通话后开始能发音，随后正常说话，恢复语言功能。询问病史，之前未发生过此类现象。头颅CT及MRI检查均未见新发梗死或出血，神经科会诊未见明确器质性病变。诊断为癔症性失语，术后5 d出院，无后遗症。随访3个月无并发症发生。

2 讨论

有关麻醉后急性失语症的现有文献有限。通常这种突发和短暂性失语症的发生可能与短暂性脑缺血发作(transient ischemic attack，TIA)[1]、声功能结构损伤[2-3]、麻醉残余效应、精神情绪改变有关[4-5]，临床上需进行鉴别诊断。

TIA是一种短暂的神经系统事件，通常持续几分钟，可因低血压、缺氧或栓塞发生。本例患者全麻过程中没有出现缺氧或低血压；ABCD2评分为4分(年龄≥60岁1分、不伴有无力的言语障碍1分、症状持续时间≥60 min 2分)，格拉斯哥评分为15分；术后头颅MRI结果正常，随访3个月无并发症，证实本例患者未出现TIA。其他神经系统病变也可引起术后语言障碍。Willson和Kapur[6]

DOI：10.3969/j.issn.1674－666X.2024.05.014

基金项目：广州市科技计划项目(2023A04J2061)

作者单位：510010 广州，中国人民解放军南部战区总医院骨科脊柱监护病区

通讯作者：陈坤，E-mail：chenkun880825@qq.com

中国知网 https://www.cnki.net

报道一例患者，全身麻醉后出现非典型性偏头痛伴呼吸暂停、失语症和偏瘫，本例通过病史和MRI评估排除神经系统病变可能。气管插管后发生的结构性损伤，包括勺状软骨脱位和喉部神经损伤均可影响发声[2,7-9]，这些原因导致的构音障碍或失语是需要治疗的。但本病例失语是一过性的，可排除声功能结构性损伤。

麻醉药物残留的神经肌肉阻滞效应可能影响神经功能。该患者能写下想说的话，对指令有良好的反应，表明神经肌肉阻滞效应已被逆转。术后谵妄可表现为语言障碍。咪达唑仑和东莨菪碱等药物已被证实会增加术后谵妄风险[10-12]。Drobish等[13]报道一例12岁健康女孩术前接受咪达唑仑治疗，术后出现一过性联想失认证和表达性失语证，使用氟马西尼拮抗咪达唑仑作用后症状即刻改善。本例患者由麻醉恢复室转监护室前曾使用2 mg咪达唑仑，虽未使用氟马西尼，但彻底清醒后仍然存在失语，暂时排除药物影响。患者简易精神评定量表评分为10分，也不支持精神疾病的诊断。

布洛卡氏失语症和韦尼克氏失语症是两种常见的失语症，布洛卡氏失语由大脑优势半球额下回（布洛卡区）受损引起，主要表现为说话困难，但能表述基本意思，能理解他人说话；韦尼克氏失语症则是由大脑优势半球颞上回（韦尼克区）受损引起，表现为不能理解他人说话，虽能流利说话，但所说的话往往无意义，伴有明显的阅读和书写障碍[14]。本例患者能写字，也能传达清晰的信息，不符合上述两种失语的诊断。

癔症性失语又称功能性失语或精神性失语，主要由精神心理因素引起，中青年妇女多见，临床表现为突然起病但恢复较快，喉部及全身检查无异常[15]。Zhang等[16]报道1例45岁女性，全麻下行腹腔镜妇科手术后出现短暂失语，失语持续约5.5 h，无栓塞风险因素，之前曾有与丈夫争吵后出现一过性失语病史，考虑失语与精神情绪障碍有关。本例患者术前存在高度紧张、惧怕麻醉和手术等情绪，加之术后在监护室一直未与家人见面，造成精神心理障碍，导致暂时丧失发声功能，符合癔症性失语的特征。患者检查过程中听家人提及长期未见、一直牵挂的孙子后情绪激动、受到刺激开始发音，与孙子通话后语言功能逐渐恢复，凸显情感支持在围术期精神障碍治疗方面的重要作用。提示加强术前教育和家人的早期陪伴可以改善手术效果。

总之，在全身麻醉后可能会出现一过性失语。诊断一过性失语应首先排除脑部并发症和咽喉部结构损伤的可能性，在排除器质性损伤及药物作用之后，还应考虑精神心理因素的可能。对于此类功能性失语患者，情感支持非常必要。

参考文献

[1] Suehiro S, Kohno K, Inoue A, et al. Two cases of cervical carotid artery stenosis with high risk post-operative hyperperfusion treated with dexmedetomidine after carotid endarterectomy [J]. No Shinkei Geka, 2010, 38(8): 731-738.

[2] Chun EH, Baik HJ, Chung RK, et al. Arytenoid cartilage dislocation mimicking bilateral vocal cord paralysis: a case report [J]. Medicine (Baltimore), 2017, 96(45): e8514.

[3] Brodsky MB, Akst LM, Jedlanek E, et al. Laryngeal injury and upper airway symptoms after endotracheal intubation during surgery: a systematic review and Meta-analysis [J]. Anesth Analg, 2021, 132(4): 1023-1032.

[4] Drexler H, Zaroura S, Shapira Y. Transient aphonia and quadriplegia during epidural anesthesia [J]. Anesth Analg, 1985, 64(3): 365-366.

[5] Parker WD Jr, Parker KC. Anesthesia-related transient aphonia and quadriplegia [J]. Anesth Analg, 1985, 64(10): 1038.

[6] Willson J, Kapur S. Apnoeic spells following general anaesthesia in a patient with familial hemiplegic migraine [J]. Anaesthesia, 2007, 62(9): 956-958.

[7] Takahoko K, Iwasaki H, Sasakawa T, et al. Unilateral hypoglossal nerve palsy after use of the laryngeal mask airway supreme [J]. Case Rep Anesthesiol, 2014, 2014: 369563.

[8] Ulusoy H, Besir A, Cekic B, et al. Transient unilateral combined paresis of the hypoglossal nerve and lingual nerve following intubation anesthesia [J]. Braz J Anesthesiol, 2014, 64(2): 124-127.

[9] Brandel MG, Lee RR, U HS. Transient aphasia following resection of a thalamic cavernous malformation [J]. World Neurosurg, 2020, 136: 390-393, e3.

[10] Aldecoa C, Bettelli G, Bilotta F, et al. Update of the European Society of Anaesthesiology and intensive care medicine evidence-based and consensus-based guideline on postoperative delirium in adult patients [J]. Eur J Anaesthesiol, 2024, 41(2): 81-108.

[11] Aldecoa C, Bettelli G, Bilotta F, et al. European Society of

中国知网 https://www.cnki.net

Anaesthesiology evidence-based and consensus-based guideline on postoperative delirium [J]. Eur J Anaesthesiol, 2017, 34(4):192-214.

[12] European Society of Anaesthesiology evidence-based and consensus-based guideline on postoperative delirium: erratum [J]. Eur J Anaesthesiol, 2018, 35(9): 718-719.

[13] Drobish JK, Kelz MB, DiPuppo PM, et al. Emergence delirium with transient associative agnosia and expressive aphasia reversed by flumazenil in a pediatric patient [J]. A A Case Rep, 2015, 4(11):148-150.

[14] Belder CRS, Marshall CR, Jiang J, et al. Primary progressive aphasia: six questions in search of an answer [J]. J Neurol, 2024, 271(2): 1028-1046.

[15] 张元贵. 全麻术后恢复早期一过性失语一例[J]. 临床麻醉学杂志, 2018, 34(7): 692.

[16] Zhang J, Yang M, Dong H, et al. Transient aphasia following general anesthesia in patient undergoing laparoscopic gynecologic surgery: a case report and literature review [J]. Clin Case Rep, 2021, 9(2): 634-637.

（收稿日期：2024-07-20；修回日期：2024-10-10）

中国知网 https://www.cnki.net